	EVOLUÇÃO ANESTESISTA INTRAOPERATÓRIO	FOR.RPA.0011/00 Implantação: 09/2024 Classificação: INTERNO PEP

PRÉ ANESTESICA	**( ) CONSULTA PRÉ ANESTESICA** **( ) AVALIAÇÃO PRÉ ANESTESICA INTRA HOSPITALAR**
HISTÓRICO MÉDICO	***(PUXAR AUTOMÁTICO)***
AVALIAÇÃO FISICA	**PESO: _____** **ALTURA:____ IMC:___*(PUXAR AUTOMÁTICO)***
ALERGIAS	***(PUXAR AUTOMATICO DA ABA DE ALERGIAS)***
HISTÓRICO DE ANESTESIA	***(PUXAR AUTOMATICO DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA)***
LISTA DE COMPLICAÇÕES ANTERIORES	***(PUXAR AUTOMATICO DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA)***
JEJUM	***(PUXAR AUTOMATICO DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA)***
PROTOCOLO DE JEJUM PROLONGADO	***PUXAR DO HISTÓRICO DE ENFERMAGEM***
TIPO DE CIRURGIA PROPOSTA	***PUXAR DO AVISO***
PORTE CIRURGICO	***PUXAR DO AVISO***
TECNICA ANESTESIACA PROPOSTA	( ) ANESTESIA GERAL (se sim abre:) 1. [ ] Anestesia Geral Venosa Total – AGVT 2. [ ] Anestesia Geral Balanceada – AGB 3. [ ] Anestesia Geral Inalatória
	( ) Bloqueio de Neuroeixo (se sim, are:) 1. [ ] Bloqueio Subaracnoideo ou Raqueanestesia - BSA 2. [ ] Bloqueio Peridural (Epidural) - BPD 3. [ ] Bloqueio Peridural (Epidural) com Cateter – BPD/CPD
	( ) Sedação 1. [ ] Sedação Consciente / Ansiólise 2. [ ] Sedação Inconsciente 3. [ ] Sedação Profunda
	( ) Anestesia Local 1. [ ] Infiltração Local 2. [ ] Bloqueio de Campo 3. [ ] Anestesia Tópica
SINAIS VITAIS ANTES DA INDUÇÃO ANESTÉSICA E NO FINAL	T: FC: FR: PA: Sat: HGT: ***[ATUALIZAR]***
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	***(PUXAR AUTOMATICO DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA)***
MANEJO DE VIA AÉREA	***(PUXAR AUTOMATICO DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA)***
ACHADOS PREDITIVOS DE VAD	***(PUXAR AUTOMATICO DA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA)***
MANEJO DE VIA AÉREA DIFICIL	( ) Videolaringoscópio ( ) Fibrobroncoscópio ( ) Máscara Laríngea ( ) Combitubo Esofágico-Traqueal (ETC) ( ) Bougies ( ) Estilete de Intubação com luz ( ) Videobroncoscópio Rígido ( ) Videobroncoscópio articulado ( ) kit cricotireoidostomia ( ) Tubo Nasotraqueal ( ) Intubação Retrógrada (técnica)
MANEJO ANESTESICO (ATUALIZAR INFORMAÇÕES)	
TIPO DE CIRURGIA REALIZADA	***PUXAR DA CONFIRMAÇÃO CIRÚRGICA***
TECNICA ANESTESIACA UTILIZADA É A MESMA PRE CONIZADA NA APA E INFORMADA AO PACIENTE	( ) SIM ( )NÃO
JUSTIFICATIVA	***CAMPO TEXTO***
MONITORIZAÇÃO	( ) PADRÃO (Cardioscopia, Oximentria, PANI) ( ) ADICIONAIS ***[abrir lista]*** - BIS/Termometro/PAM/PVC/TOF/DC
DURAÇÃO DA CIRURGIA	PUXAR DA DESCRIÇÃO CIRURGICA

AGENTES ANESTÉSICOS ADMINISTRADOS	LISTA CAIXA PSICOBOX (+)
MEDICAÇÕES ADMINISTRADAS DURANTE A CIRURGIA	PUXAR DA PRESCRIÇÃO Medicações administradas durante a cirurgia (deve estar na prescrição conforme doses e horários adequados), DOSE E HORÁRIO

MANEJO DE VIA AÉREA	( ) VIA AÉREA NORMAL ( ) VIA AÉREA DIFÍCIL (Abre material UTILIZADO:) ( ) Tubo Endotraqueal Videolaringoscópio ( ) Fibrobroncoscópio ( ) Máscara Laríngea ( ) Combitubo Esofágico-Traqueal (ETC) ( ) Bougies ( ) Estilete de Intubação com luz ( ) Videobroncoscópio Rígido ( ) Videobroncoscópio articulado ( ) kit cricotireoidostomia ( ) Tubo Nasotraqueal ( ) Intubação Retrógrada (técnica)
EVENTOS INTRAOPERATÓRIOS RELEVANTES	( ) NÃO ( ) SIM *[abrir lista]* *[LISTA]* • Broncoespasmo • Laringoespasmo • Hipotensão • Hipertensão • Bradicardia • Arritmias Cardíacas • Hipóxia • Hipercapnia • Hipocapnia • Hemorragia • Embolia • Aspiração Pulmonar • Despertar Intraoperatório • Reações Alérgicas / Anafilaxia • Hipertermia Maligna • Alterações nos gases sanguíneos arteriais • Alterações na coagulação sanguínea • Lesões iatrogênicas (por exemplo, perfuração de órgãos) • Alterações na temperatura corporal prejudiciais • Dificuldade no manejo da via aérea • Alterações neurológicas (por exemplo, convulsões) • Complicações relacionadas a dispositivos médicos (por exemplo, falha de monitores ou equipamentos) • Outros:_____ *[/LISTA]*
DESCRIÇÃO EVENTO	*Campo texto*
BALANÇO HÍDRICO INTRAOPERATÓRIO	*Puxar valores da aba BH*
HEMODINAMICA INTRAOPERATÓRIA	*Puxar lista sinais vitais intra operatório (+)*
OBSERVAÇÕES	*Campo texto*

RELATÓRIO DE PASSAGEM DE PLANTÃO ENTRE A EQUIPE CIRÚRGICA E PÓS-OPERATÓRIO			
LOCAL DE RECUPERAÇÃO INDICADO	*Puxar de acordo com a classificação ASA, Porte Cirúrgico e Transoperatório*		
LOCAL DE RECUPERAÇÃO	1. *Recuperação em SRPA padrão.* 2. *Recuperação em UTI.*		
JUSTIFICATIVA	*Campo texto obrigatório em caso de divergência*		
ESTADO PÓS-OPERATÓRIO	*Campo texto*		
ALARMES CLÍNICOS DURANTE PARA A RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA	**( ) Asa I** **( ) ASA II – Cirurgias de pequeno e médio porte (** **) ASA I e II – Cirurgias de grande porte** **( ) ASA III e IV**		
	( ) Parametrização padrão **( ) Parametrização individualizada:** [abrir campo limites de alarme]		
	LIMITES DE ALARME	**MÁXIMO (até vairacao de 20% do primeiro em sala)**	**MÍNIMO (ate variação de 20% do primeiro em sala)**
	FC		
	SPO2		
	PA Sistólica		
	PA Diastólica		
	FR		
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PÓS-OPERATÓRIAS	*Campo texto*		
ANESTESIOLOGISTA RESPONSÁVEL	*ASSINATURA ELETRÔNICA*		

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

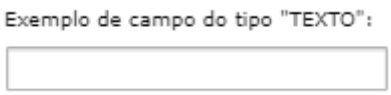
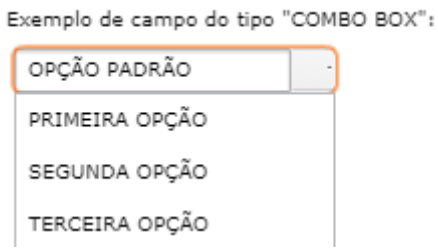
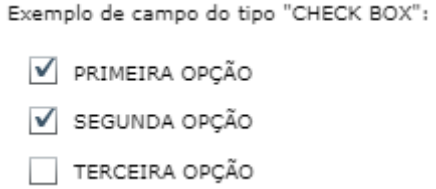
As informações técnicas têm como objetivo esclarecer as diretrizes técnicas para a construção do documento eletrônico, incluindo a especificação de campos, a localização das informações e quaisquer questionamentos identificados na análise inicial realizada pela equipe de TI.

Questionamentos técnicos:

1. **Definição do Aviso Cirúrgico**: O documento não apresenta de forma clara qual é o Aviso Cirúrgico que deve ser usado. Essa falta de definição impede o preenchimento automático de vários campos e compromete o funcionamento correto dos processos que dependem dessa informação.

2. **Diferenças entre Relatório e Documento Eletrônico**: O conceito de um documento eletrônico envolve a interação entre o usuário (médico, enfermeiro ou técnico) e o sistema, permitindo a inserção de dados. No documento atual, porém, dos 40 campos existentes, 19 são apenas para consulta de informações que já estão disponíveis em outro lugar. Ou seja, metade do documento é usada apenas para exibir informações, sem necessidade de interação. A recomendação técnica, nesse caso, é que as informações consultivas sejam reunidas em um relatório separado, mantendo no documento eletrônico apenas os campos onde o usuário realmente precisa inserir dados.

Legenda de campos:

Texto  	Indicado para frases curtas.
Combobox  	Permite selecionar um valor dentre uma lista de valores possíveis, que pode ser uma lista fixa ou uma lista dinâmica.
Checkbox  	Permite a seleção de várias opções simultaneamente.

Caixa de texto Exemplo de campo do tipo "CAIXA DE TEXTO":	Campo para inserção de textos maiores.
Radio button Exemplo de campo do tipo "RADIO BUTTON": PRIMEIRA OPÇÃO SEGUNDA OPÇÃO TERCEIRA OPÇÃO	Permite a seleção de apenas uma opção dentre as exibidas.

Campos	Obrigatoriedade do campo na finalização do documento	Tipo do campo	Detalhamento
PRÉ ANESTESICA	**SIM**	**Checkbox**	**N/A**
HISTÓRICO MÉDICO	**SIM**	**Caixa de Texto**	**No PEP rotina enfermeiro > Centro Cirúrgico > Histórico. Puxar apenas os campos preenchidos das comorbidades: TODAS** **OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO**
AVALIAÇÃO FISICA	**SIM**	**Caixa de Texto**	**No PEP rotina enfermeiro > Centro Cirúrgico > CSV > MEDIDAS. PESO ALTURA E FORMULAS IMC**
ALERGIAS		**Caixa de Texto**	**No PEP rotina Téc. Enfermagem > Alergias: puxar todas as cadastradas.** **OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO**
HISTÓRICO DE ANESTESIA		**Caixa de Texto**	**No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo ANESTESIAS ANTERIORES** **OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.**
LISTA DE COMPLICAÇÕES ANTERIORES		Combobox PODENDO ADICIONAR MAIS DE UMA OPÇÃO DE ESCOLHA	**No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo LISTA DE COMPLICAÇÕES PASSADA** **OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.**

JEJUM		Combobox	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo JEJUM OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.
PROTOCOLO DE JEJUM PROLONGADO		Checkbox	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo PROTOCOLO DE JEJUM PROLONGADO OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.
TIPO DE CIRURGIA PROPOSTA		Caixa de Texto	No PEP rotina Téc. Enfermagem > AVISO CIRÚRGIA> CIRÚRGIA A SEREM REALIZADAS>PROCED
PORTE CIRURGICO		Caixa de Texto	
TECNICA ANESTESIACA PROPOSTA		Combobox	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo PROTOCOLO DE JEJUM PROLONGADO OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.
SINAIS VITAIS ANTES DA INDUÇÃO ANESTÉSICA E NO FINAL		Caixa de Texto	No PEP rotina enfermeiro > Centro Cirúrgico > CSV > PUXAR OS SINAIS VITAIS VERIFICADOS NO PRÉ-OPERATORIO
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS		Combobox PODENDO ADICIONAR MAIS DE UMA	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.
MANEJO DE VIA AÉREA		Combobox	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo MANEJO DE VIA AÉREA OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATORIA NÃO EXISTA.
ACHADOS PREDITIVOS DE VAD		Texto	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo ACHADOS PREDITIVOS DE VAD OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO OU PREENCHIDO CASO A AVALIAÇÃO PRÉ-

			OPERATORIA NÃO EXISTA.
MANEJO DE VIA AÉREA DIFICIL		Combobox	O campo será preenchido pelo profissional
TIPO DE CIRURGIA REALIZADA		Combobox	O campo será preenchido pelo profissional
TECNICA ANESTESIACA UTILIZADA É A MESMA PRE CONIZADA NA APA E INFORMADA AO PACIENTE		Radio button	O campo será preenchido pelo profissional
JUSTIFICATIVA		Caixa de texto	Esse campo possui relação com campo TECNICA ANESTESIACA UTILIZADA É A MESMA PRE CONIZADA NA APA E INFORMADA AO PACIENTE, no caso da resposta for NÃO o preenchimento da justificativa deve ser obrigatório.
MONITORIZAÇÃO		Checkbox	O campo será preenchido pelo profissional
DURAÇÃO DA CIRURGIA		Texto	No PEP rotina enfermeiro > Centro Cirúrgico >descrição cirurgia.CALCULAR O TEMPO ENTRE OS CAMPOS . data de inicio da cirurgia e data fim da cirurgia.
AGENTES ANESTÉSICOS ADMINISTRADOS	SIM	Caixa de texto	
MEDICAÇÕES ADMINISTRADAS DURANTE A CIRURGIA	SIM	Caixa de texto	No PEP rotina MÉDICA > ANESTESISTA>PRESCRIÇÃO>PUXAR LISTA DE ITENS PRESCRITOS.
MANEJO DE VIA AÉREA		Combobox	O campo será preenchido pelo profissional
EVENTOS INTRAOPERATÓRIOS RELEVANTES		Combobox	O campo será preenchido pelo profissional
DESCRIÇÃO EVENTO	SIM	Caixa de texto	TORNAR CAMPO OBRIGATÓRIO CASO INFORME A OCORRENCIA DE ALGUM EVENTO INTRAOPERATORIO RELEVANTE
BALANÇO HÍDRICO INTRAOPERATÓRIO		Texto	No PEP rotina Téc. Enfermagem > BH>TOTAIS> TOTAL POR POR HORA (CAMPOS PREENCHIDOS)
HEMODINAMICA INTRAOPERATÓRIA		Texto	No PEP rotina Téc. Enfermagem >CSV>puxar os registros dos SINAIS VITAIS DO INTRAOPERATÓRIO
OBSERVAÇÕES		Caixa de texto	Ok
LOCAL DE RECUPERAÇÃO INDICADO		Checkbox	No PEP na aba da Anestesia . Avaliação pré-operatoria. puxar as informações preenchidas do campo LOCAL DE RECUPERAÇÃO
LOCAL DE RECUPERAÇÃO		Checkbox	O campo será preenchido pelo profissional
JUSTIFICATIVA		Caixa de texto	O campo será preenchido pelo profissional
ESTADO PÓS-OPERATÓRIO		Caixa de texto	O campo será preenchido pelo profissional
ALARMES CLÍNICOS DURANTE PARA A RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA		Checkbox, combobox, texto	O campo será preenchido pelo profissional
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS		Caixa de texto	Ok

PÓS-OPERATÓRIAS			